Psychologie et développement au fil de la vie

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Cours et application

Toute la vie

Le développement comprend les transformations et continuités de la naissance à la vieillesse. Il associe maturation, expérience, relations et contexte social.

Psychomoteur

Le contrôle postural et les acquisitions motrices se construisent progressivement. Les directions céphalocaudale et proximodistale sont des repères généraux, pas des calendriers individuels stricts.

Langage

Le développement langagier associe compréhension, expression et échanges. Les âges des premières acquisitions varient ; distinguer un repère pédagogique d’un diagnostic.

Socioaffectif

La disponibilité des proches, la sécurité relationnelle et les interactions soutiennent l’exploration et la régulation des émotions. Ne pas déduire un fonctionnement psychique d’un seul comportement.

Modèles

Wallon, Freud et Erikson proposent des cadres différents. Présenter leurs stades comme des modèles théoriques et historiques, sans transformer une tranche d’âge ou un conflit en loi universelle.

Adulte

Études, travail, relations, parentalité, changements corporels et pertes éventuelles s’inscrivent dans des parcours singuliers. Les normes sociales ne définissent pas à elles seules une trajectoire normale.

Acquisitions et observation du nourrisson

Les notes citent le score d’Apgar et plusieurs réflexes du nourrisson. Le score d’Apgar décrit l’adaptation du nouveau-né à des temps définis ; il ne constitue pas une mesure globale de son développement futur. Les réflexes et le tonus s’apprécient dans un examen adapté, par un professionnel compétent.

Les acquisitions posturales et motrices se construisent avec la maturation et les expériences. Les directions céphalocaudale et proximodistale décrivent des tendances du contrôle moteur. Elles ne permettent pas de prévoir exactement la date d’acquisition d’un enfant.

Pour observer, préciser ce qui a été fait spontanément ou avec aide, dans quelles conditions et à quel moment. La fatigue, le contexte, la santé et les possibilités d’exploration influencent la performance. Comparer plusieurs observations et transmettre une difficulté persistante sans poser de diagnostic à partir d’un âge isolé.

La relation de soin soutient la sécurité, le confort et la participation des proches. Adapter le matériel et les stimulations à l’enfant. Les notes du cours sont des repères d’apprentissage ; les fiches A5 déjà présentes détaillent Apgar, réflexes et développement postural.

Langage, émotions et relations

Les premières communications comportent regards, expressions, mouvements et vocalisations. Compréhension et expression ne progressent pas nécessairement au même rythme. Le contexte linguistique et les occasions d’échange doivent être pris en compte.

Les notes présentent des âges et quantités de mots. Ces chiffres ne sont pas repris comme des seuils diagnostiques : les sources et les conditions de comptage ne sont pas précisées. Observer la communication fonctionnelle, les interactions et l’évolution avant de conclure.

Le développement socioaffectif associe progressivement différenciation, exploration, autonomie et relations. Les émotions jouent un rôle dans les interactions et la recherche de sécurité. L’enfant peut avoir besoin d’un adulte pour l’aider à réguler un état émotionnel intense.

Wallon met l’accent sur les liens entre dimensions motrices, affectives et sociales. Les comportements peuvent avoir plusieurs fonctions selon le contexte. En soins, expliquer avec des mots adaptés, laisser une possibilité de participation et rechercher ce qui rassure réellement cet enfant.

Théories des stades et trajectoires adultes

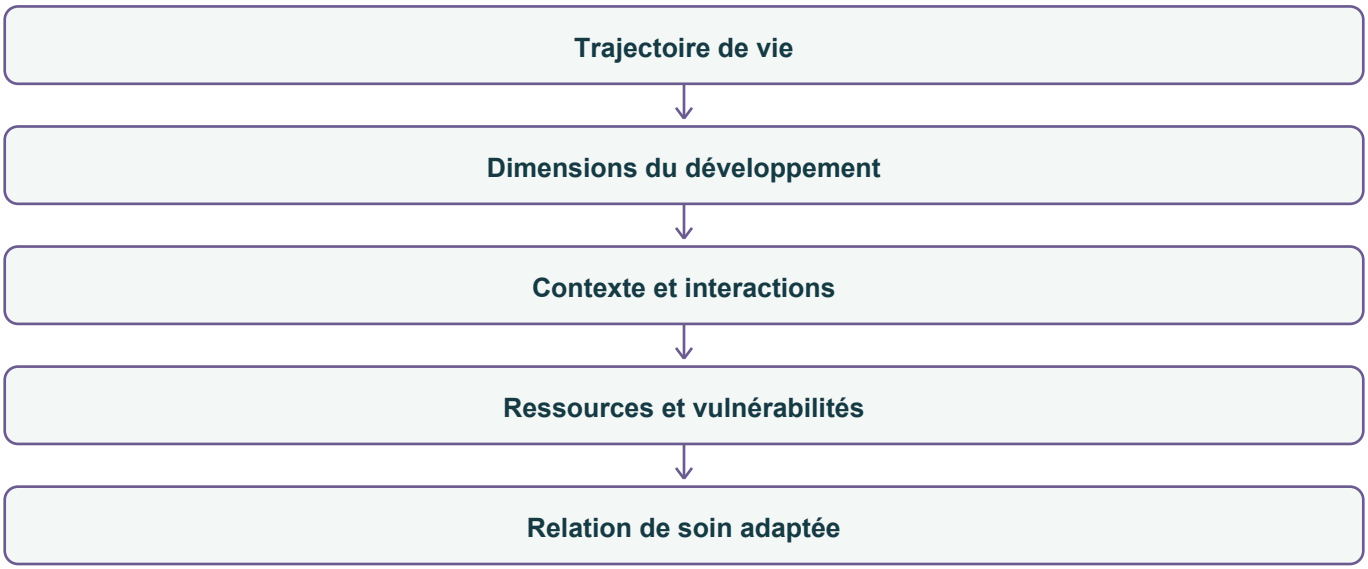
Dans le cadre psychanalytique freudien présenté dans le cours, les stades oral, anal, phallique, la latence et l'organisation génitale décrivent un modèle du développement psychoaffectif. Le complexe d'Œdipe appartient à ce cadre. Ces notions ne sont pas des faits biologiques permettant de classer chaque enfant ni des outils diagnostiques immédiats.

Erikson propose des tensions psychosociales au fil de la vie : confiance et méfiance, autonomie et honte/doute, initiative et culpabilité, activité et infériorité, identité et confusion, intimité et isolement, générativité et stagnation, intégrité et désespoir. Les âges sont des repères du modèle et les parcours ne suivent pas tous une chronologie identique.

L'adolescence peut associer transformations corporelles, recherche d'identité, nouveaux liens et remaniements familiaux. Éviter de réduire cette période à une crise inévitable. Écouter la personne, ses ressources et ses éventuelles difficultés dans son contexte.

À l'âge adulte, les événements de vie peuvent modifier les rôles, les priorités et l'image de soi. Les formes de vie conjugale, professionnelle ou familiale sont diverses. En soins, partir de ce que la personne exprime et de ses soutiens ; ne pas imposer comme norme un calendrier social de mariage, parentalité ou carrière.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Le développement s’arrête-t-il après l’enfance ? Non.

Une tranche d’âge d’un modèle est-elle un diagnostic ? Non.

Les dimensions motrices, affectives et sociales sont-elles indépendantes ? Non, elles interagissent.

Sources et portée

UE B2 CM PSCHOLOGIE ET DEVELOPPEMENT.docx

Rattachement au thème établi à partir des documents transmis ; ressource exacte ou capsule non vérifiée.